PROTOCOLLO 67

Controllo della postura linguale in deglutizione

Correggere la deglutizione con spinta linguale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Disturbi del controllo orale	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Deglutizione atipica
- ✓ Interposizione linguale
- ✓ Tensione sopraioidea

Controindicazioni e precauzioni

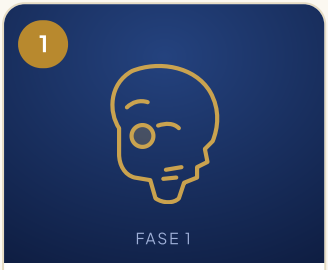
- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione

Punta della lingua al palato dietro gli incisivi.



Deglutizione

Deglutisci un sorso d'acqua mantenendo la lingua.



Labbra

Labbra rilassate, senza contrazione del mento.



Ripetizione

Ripeti con piccoli sorsi.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10
Serie	3 al giorno
Supporto	specchio

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Collabora con il logopedista se necessario
- ✓ Movimento lento
- ✓ Feedback allo specchio

Errori da evitare

- ! Contrarre il mento
- ! Spingere la lingua sui denti
- ! Sorsi troppo grandi

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Deglutizione corretta	Deglutire piccoli sorsi con lingua al palato	10 ripetizioni, 3 volte al giorno

! **Nota clinica.** In caso di deglutizione atipica strutturata, coinvolgi il logopedista.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.